救急臨床推論（実践編）

中村　哲久

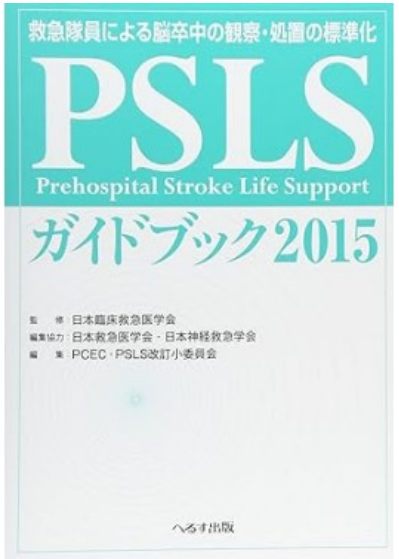
臨床推論

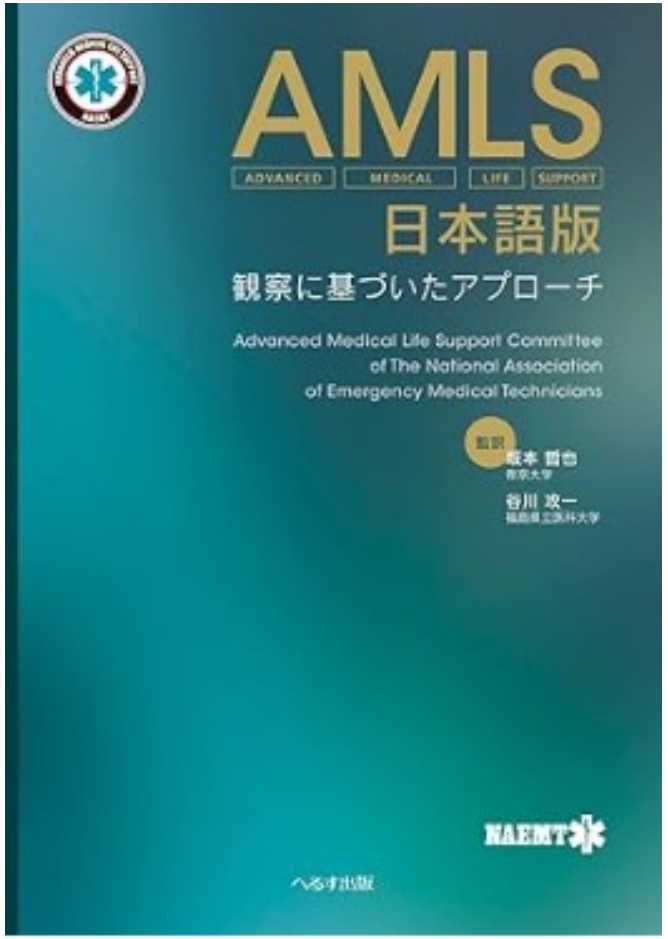
- 臨床推論あるいは診断推論
- 診断学、症候学に基づいて鑑別診断を進める
- 診断学：主に問診（主訴、現病歴、既往歴）から鑑別診断を行う
- 症候学：主に診察（視診、触診、聴診、打診）から鑑別診断を行う
- 日常診療の診断で7割は病歴で可能

病院前救護の標準化

救急隊員による疾病の観察・処置の標準化
PEMEC
Prehospital Emergency Medical Evaluation and Care
ガイドブック2023
監　修：日本臨床救急医学会
編　集：日本臨床救急医学会 PEMECガイドブック改訂に関する編集委員会
編集協力：日本臨床救急医学会 PEMEC企画運営小委員会・小児救急委員会
へるす出版

改訂6版
救急蘇生法の指針2020
医療従事者用
へるす出版


救急隊員による脳卒中の観察・処置の標準化
PSLS
Prehospital Stroke Life Support
ガイドブック2015
監　修：日本臨床救急医学会
編集協力：日本救急医学会・日本神経救急学会
編　集：PCEC・PSLS改訂小委員会
へるす出版


AMLS
ADVANCED MEDICAL LIFE SUPPORT
日本語版
観察に基づいたアプローチ
Advanced Medical Life Support Committee
of The National Association
of Emergency Medical Technicians
監訳
谷川 攻一
NAEMT
へるす出版

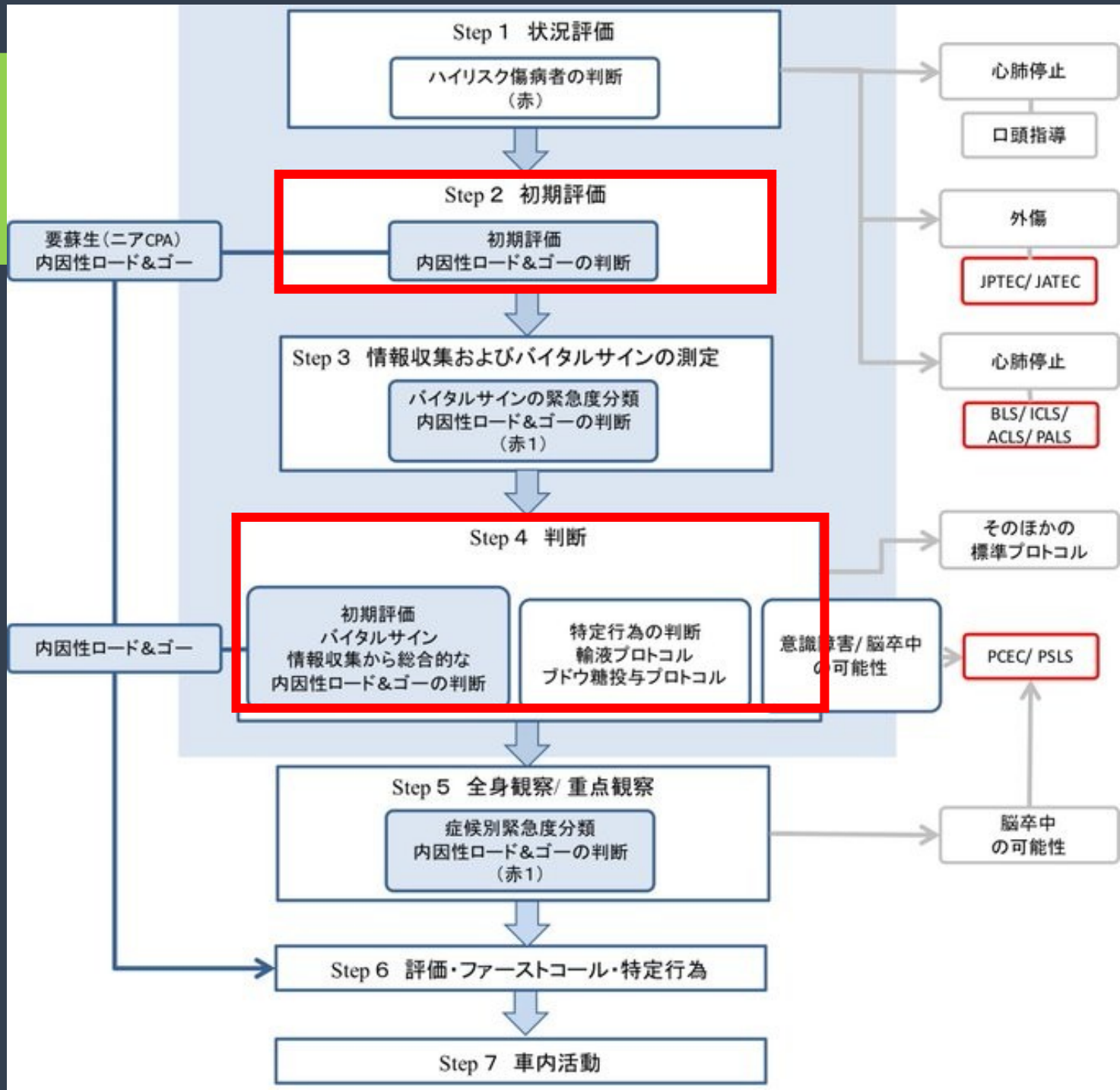
救急隊員による意識障害の観察・処置の標準化
PCEC
Prehospital Coma Evaluation and Care
ガイドブック2016
へるす出版

JRC
蘇生ガイドライン
2020
その生命を
繋ぎ止めるために

JPTEC
ガイドブック
Load and Go
The right patient in the right time to the right place

PEMEC

早い段階で
ファーストコール



出場～現着まで　STEP 1

通報内容から病態を３つくらい上げる。

例：通報内容

ハイリスク症候
内因性ロード＆ゴーを考慮

出場～現着まで　STEP 1

- 考えられる疾患を考えたら・・

- 感染防護衣の確認（PPE の再確認）
- 増隊は？（PA ？ Dr カー or ヘリ）
- 現場にもっていく資機材は？
- 医療機関はどこに搬送する可能性があるのか？

現着～傷病者接触まで　STEP 1

- 何はともあれ現場の安全確認　３Ｓ

異臭は？（CO 中毒 etc）

部屋は散らかってる？

(生活環境の確認、薬剤の大量服用の確認)

犬とかいない？

凶器はない？

現着～傷病者接触まで　STEP 1

- 傷病者は１人？多数症のスイッチはいらない？

⇒ 多数症なら多数傷プロトコル (MCLS)

- 外傷はない？

⇒ 交通外傷、労災、一般負傷（JPTEC）

- 多数症でも外傷でもなさそうだ。
- 傷病者に近づこう！！

現着～傷病者接触まで　STEP2

- 傷病者にいきなり声をかけるのは NG

傷病者の意識レベルは AVPU でどうか？

意識レベルは３ステップ法

まずは開眼してるか見る。

次に声をかけてみる。ここで開眼なら V もしくは JCS10

声掛けで開眼しない・・しょうがないから圧迫刺激

P、U もしくは JCSII 桁～III 桁

現着～傷病者接触まで　STEP2

- 傷病者にいきなり声をかけるのは NG

傷病者の姿勢はどうか？

坐位？起坐呼吸？⇒ CPA ではないかな。

ショック、呼吸不全かも。

顔色は？

呼吸様式は？明らかにおおきな呼吸（クスマウルの呼吸）

嘔吐痕や失禁、出血は？（意識消失や外傷の確認）

初期評価　STEP 2

ABCD

- A ・・気道の確認及び処置（気道確保、吸引、エアウェ

内因性ロード＆ゴー
観察基準表A,B

- D ・・意識障害の有無

初期評価　STEP2→6

内因性ロード＆ゴーなら

最低限の処置やってファーストコール！！！

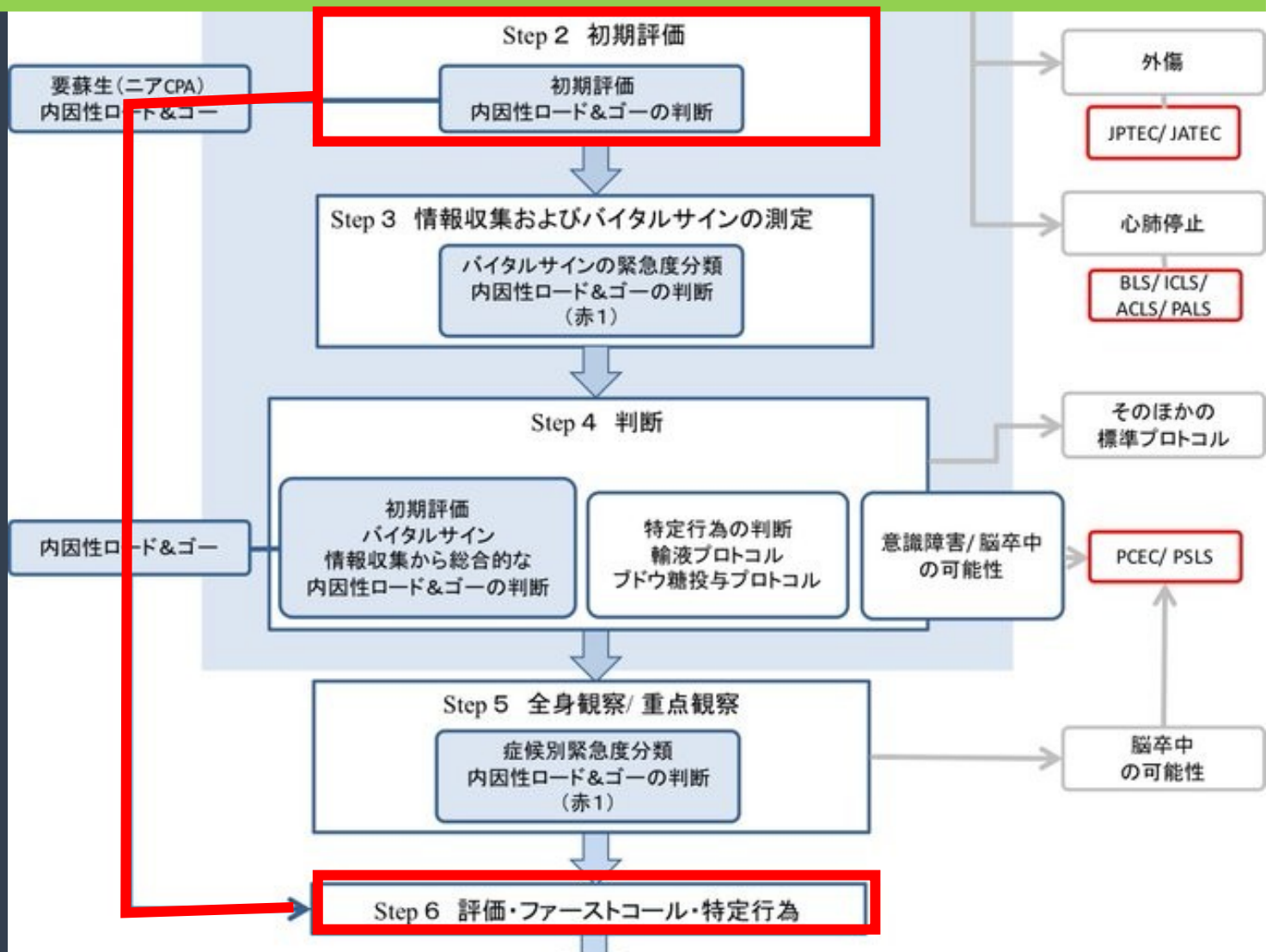
地域事情は分かるけど、

内因性ロード＆ゴーの病院は限られる。住所やら生年月日なんて後回し。情報は病着時までにまとまってればいい。必要な情報はセカンドコールで十分。

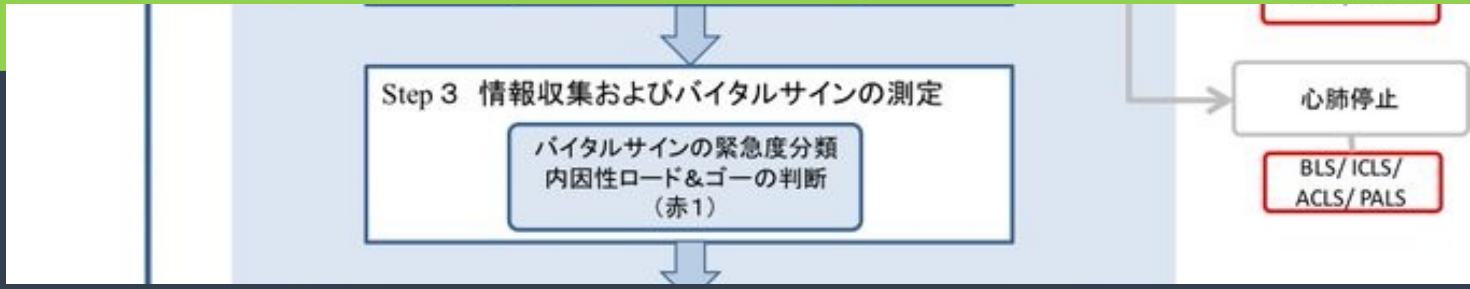
初期評価　STEP2→6

もちろん、時間の許す限り情報収集とバイタル測定は必要。

情報収集は何を聞けばいい？



OPQRST　現病歴メイン　STEP 3



- ~~O　Onset: 発症様式~~
- P　Palliative & Provocative Factors: 軽快、増悪因子
- Q　Quality & Quantity: 性質と程度
- R　Region & Radiation: 部位と放散
- S　Symptoms/Associated: 随伴症状
- ~~T　Time Course: 時間経過~~

発症様式

- 突然？徐々に？

  大体の傷病者は急に起きたと言う

- 突然とは・・

何をしているときに痛くなったのか言える！！！

随伴症状

- 交感神経

  冷汗、冷感、動悸など

- 副交感神経

  悪心、嘔気、失禁など

時間経過

- 間欠的 vs 持続的
- 軽快傾向 vs 増悪傾向

  ⇒持続、増悪は重症度、緊急度が高い可能性がある
- 持続するとは、

  繰り返す、再発することも含む

「一時も症状はなくならなかったですか？」

SAMPLER　既往歴メイン　STEP 3

- S　Sign & symptom: 主訴
- A　Allergy: アレルギー
- M　Medication: 内服
- P　Past medical history: 既往歴
- L　Last meal: 最終食事
- R　Risk factor: 危険因子

判断　STEP 4

- 初期評価、情報収集、バイタル測定から

  内因性ロード＆ゴーを判断

- 特定行為が必要なら・・・

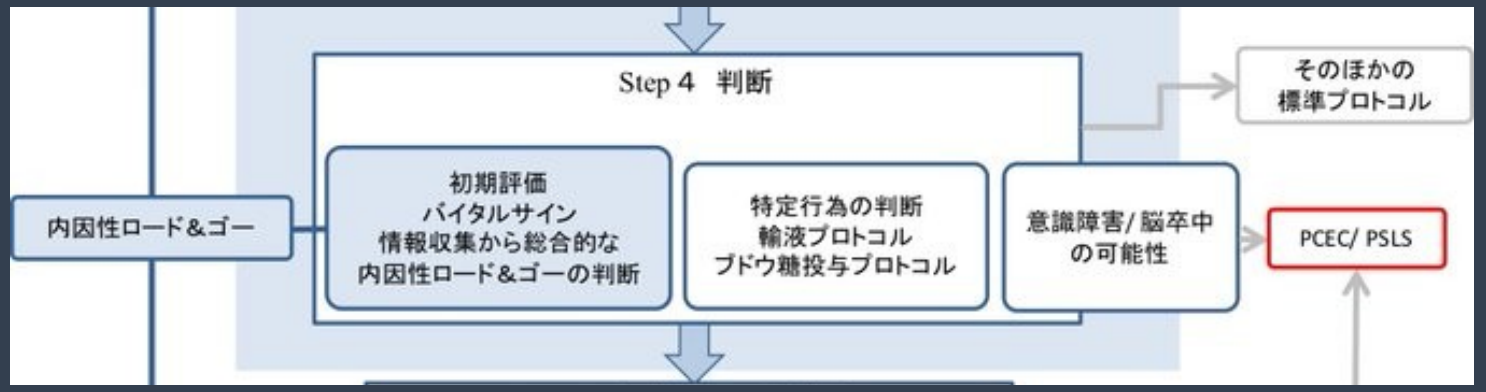
  輸液プロトコル or ブドウ糖プロトコル

- 意識障害なら・・・

  PCEC

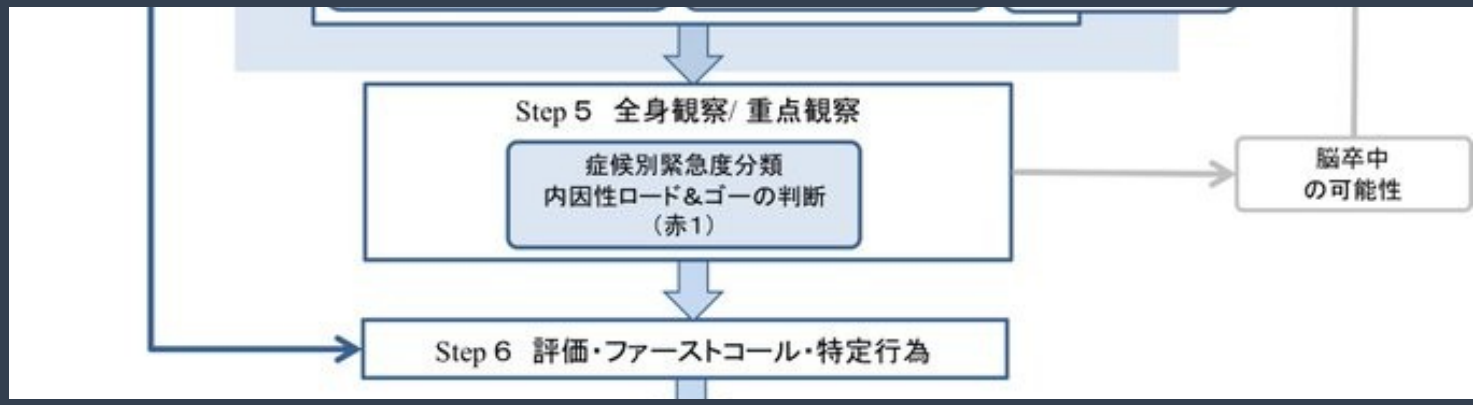
- 脳卒中疑いなら・・・

  PSLS



全身観察 / 重点観察　STEP 5

- 症候別緊急度分類
- 詳しくは別途スライドにて
- 内因性ロードアンドゴーの判断



ファーストコール　STEP6

- I:Identify(報告書、対象者の同定)
- S:Situation(状況、状態)
- B:Background(背景、経過)
- A:Assessment(評価)
- R:Recommendation(依頼、要請)
- C:Confirm(口頭指示の復唱、確認)

ファーストコール　STEP6

- I ： Identify(６０歳、男性)
- S:Situation(テレビを見ていたところ急に胸痛を起こしました。心電図モニター上、 ST 上昇しています。)
- B:Background(狭心症の既往歴があり、痛みは２０分以上継続しています。)
- A:Assessment(心筋梗塞の疑いです)
- R:Recommendation(心原性ショックに対する輸液はいかがでしょうか？また収容いかがでしょうか？)
- C:Confirm(維持輸液で投与します。収容まで２０分です。)

ファーストコール　STEP6

- 年齢、性別
- 依頼内容（収容依頼？特定行為指示要請？助言？）
- メインの状態（救急現場を一言でいうと）

要は結論を頭にもってこい！

処置は、酸素投与。搬送中に静脈路確保を実施したいのでがよろしいですか？

情報聴取のポイント

いる情報

いらない情報

いる情報

年齢、性別

ショックあり、なし

主訴、メインの所見

既往歴

発症時間

いらない情報（ファーストコール）

- 傷病者の漢字
- 住所
- コロナ有無
- **発生状況の詳細　５Ｗ１Ｈ**

では、やってみましょう！！